

表 4 IPF 急性増悪期の治療

CQ	推奨文	推奨の強さ	エビデンスの強さ
CQ10: IPF 急性増悪患者にパルス療法を含めたステロイド療法は推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対してパルス療法を含めたステロイド療法を行うことを提案するが、一部の患者にはこの治療法が合理的な選択肢でない可能性がある。	2	D (非常に低)
CQ11: IPF 急性増悪患者に免疫抑制薬は推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対して免疫抑制薬を投与しないことを提案するが、一部の患者にはこの治療法が合理的な選択肢である可能性がある。	2	C (低)
CQ12: IPF 急性増悪患者に好中球エラスターゼ阻害薬は推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対して好中球エラスターゼ阻害薬を投与しないことを提案する。	2	D (非常に低)
CQ13: IPF 急性増悪患者に PMX-DHP 療法は推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対して PMX-DHP 療法を行わないことを提案するが、一部の患者にはこの治療法が合理的な選択肢である可能性がある。	2	C (低)
CQ14: IPF 急性増悪患者にリコンビナントトロンボモジュリンは推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対してリコンビナントトロンボモジュリンを投与しないことを提案する。	2	B (中)
CQ15: IPF 急性増悪患者に抗線維化薬を新たに投与することは推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対して抗線維化薬を新たに投与しないことを提案する。	2	D (非常に低)
CQ16: IPF 急性増悪患者に高流量鼻カニュラ (HFNC) 酸素療法および非侵襲的陽圧換気療法 (NPPV) は推奨されるか?	IPF 急性増悪患者に対して非侵襲的呼吸補助 (HFNC, NPPV) を行うことを提案するが、一部の患者にはこの治療法が合理的な選択肢でない可能性がある。	2	D (非常に低)

PMX: polymyxin B 固定カラムを用いた血液直接灌流法

[厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策事業「びまん性肺疾患に関する調査研究」班特発性肺線維症の治療ガイドライン作成委員会：特発性肺線維症の治療ガイドライン 2023 改訂第2版，南江堂，2023 より作成]

また、国内・国外ともに IPF は肺移植適応疾患として認められている。一般的な肺移植適応基準（呼吸器学総論 V-22 参照）に加えて、IPF の場合は、① DLco が予測値の 39% 未満である、② 6 ヶ月間で FVC が 10% 以上低下している、③ 6 分間歩行テスト中に SpO₂ が 88% 未満である、④ HRCT で蜂巢肺を示す (fibrosis score > 2)、のいずれかを満たす場合に移植適応と判断される。

急性増悪の治療については、本邦のガイドライン (表 4) に記載されているが、いずれもエビデンスの質は低いものの、パルス療法を含めたステロイド療法が提案されている^{4,6)}。免疫抑制薬としては、高用量ステロイドに cyclophosphamide を併用した群としない群の無作為化比較試験が行われ、併用群の 3 ヶ月死亡が高い傾向であったことが報告されている。その他、小規模後ろ向き cyclosporin や tacrolimus の研究が報告されている。

b 予 後

IPF の診断確定後の平均生存期間は 3~5 年間と報告されてきたが、抗線維化薬を適正に使用することにより、生命予後が改善されているというデータが収集され始めている。また、2027 年に新たな抗線維化薬の市販が予定されている。IPF の急性増悪についても平均生存期間は 2 ヶ月以内と報告されてきたが、近年の報告では 3 ヶ月生存率が 50% を上回るようになってきている。

2

非特異性間質性肺炎

nonspecific interstitial pneumonia (NSIP)

到達目標

- ◆ 非特異性間質性肺炎 (NSIP) の特徴が説明できる
- ◆ NSIP の症候と身体所見が説明できる
- ◆ NSIP の画像所見が説明できる
- ◆ NSIP の診断、治療が説明できる

病因・病態・疫学

a 疾患概念

原因不明の間質性肺炎である特発性間質性肺炎 (idiopathic interstitial pneumonias: IIPs) のうち、非特異性間質性肺炎 (NSIP) は、組織学的に空間的・時相的に均一な病変分布を示すことが特徴で、病変分布が不均一である特発性肺線維症 (idiopathic pulmonary fibrosis: IPF) とならんで慢性線維化性間質性肺炎に属する⁷⁾。抗線維化薬が治療の主体である IPF と異なり、NSIP は副腎皮質ステロイド・免疫抑制薬が治療の中核をなす。治療法の方角性が大きく異なるにもかかわらず、診断はしばしば困難であり、外科的肺生検による組織採取、呼吸器・放射線・病理専門医による multi-disciplinary discussion (MDD) による診断が必要である。膠原病肺・過敏性肺炎・薬剤性肺炎などは、病理学的、放射線学的に NSIP パターンを呈することがあるため、特発性 NSIP の診断時には二次性の間質性肺炎の除外、経過中には膠原病の出